



電生理檢查與電燒手術

找出心律不整的「起源點」或「迴路」，必要時同次以熱能或冷凍阻斷

適用心室上頻脈與心室性心律不整；心房顫動另有單張



掃描看電子版

① 這是什麼檢查與治療？

電生理檢查（EPS）

放入細導管記錄電訊號，必要時短暫刺激

導管消融（電燒）

位置與風險適合時，同次以熱能或冷凍阻斷

不需開胸，但屬侵入性處置

② 哪些人可能需要評估？

心室上頻脈（SVT）

反覆突發心悸、頭暈、昏厥；藥物無效、不耐受或希望根治者可討論電燒

心室早期收縮（PVC）

症狀明顯、數量頻繁，或疑似影響心功能

心室頻脈（VT） ICD 反覆放電、藥物難控

③ 當天怎麼進行？

檢查結果與安全性，決定是否同次電燒

1 準備與麻醉

導管室監測心電圖、血壓、血氧；鼠蹊部局部麻醉，是否加鎮靜或全身麻醉依心律型態與院方評估

2 放入導管

經靜脈，有時需經動脈或進入左心系統；導管記錄訊號並嘗試誘發。誘發時可能感到心悸，醫護全程監測

3 定位與消融

找到病灶且適合治療時，以熱能或冷凍阻斷；複雜心律不整會用三維定位

4 再測試

治療後再確認能否誘發；若無法誘發或風險過高，可能只完成檢查

④ 什麼時候會用到「三維立體定位」？

依心律型態決定，不是每個人都需要

常需要三維定位的情況

心房頻脈、心房撲動（尤其非典型）

心室早期收縮、心室頻脈

好處：大幅減少 X 光、提高定位精準度

高密度標測導管

多電極導管一次採集上萬個點，

看得出疤痕邊緣的細小傳導通道

用於術後心房頻脈、疤痕相關心室頻脈

⑤ 風險與限制

較常見

穿刺處疼痛、瘀青、出血或血腫；

心悸可能復發，少數需再次治療

較少見但重要

血管傷害、心包積液、血栓中風、感染；

靠近房室結者可能傳導阻滯而需節律器

⑥ 術前術後重點

術前 告知用藥與保健品、過敏、腎功能、

懷孕可能、是否裝有節律器 / ICD

抗心律不整藥與抗凝血藥一律依醫師指示，切勿自行停

術後 依指示平躺、穿刺側腰部不彎；

約一週避免提重物、劇烈運動與用力蹲起

⑦ 大約的成功率與風險

依心律型態與個人狀況而異，請以醫師對「您的」情況評估為準

房室結迴路 AVNRT

95~98%

典型心房撲動

>95%

旁路迴路 AVRT

90~95%

嚴重併發症：每 100 人約 1~2 人（紅點）



其中因傳導阻滯而需裝節律器者不到 1 人

⑧ 出現這些情況，就近就醫或立即撥打 119

穿刺處持續出血或快速腫大 | 腳冰冷麻木 | 胸痛 | 嚴重喘 | 昏厥 | 發燒 | 單側無力或口齒不清

提醒：沒有一個適用所有人的成功率或住院天數。請向醫師詢問「我的」心律型態、預期效益與個人風險。

資料來源（查核至 2026-09）：

2019 ESC 心室上頻脈診療指引；2022 ESC 心室性心律不整與猝死預防指引；

衛生福利部中央健康保險署 自費醫材告知及同意規範；中華民國心臟學會相關心律不整臨床建議。

© 2026 林祐騰醫師 編製 本單張僅供臨床衛教使用，未經同意請勿重製、改作或作商業用途。